法說會重點摘要

藥華藥

(6446 TT, NT$1,335, 增加持股)

重點摘要

1. 藥華藥 3Q26 營收 77.6 億元，QoQ +13%，YoY 近翻倍，主因美國與日本銷量成長、Ropeg 注射筆於美國上市，以及美日原發性血小板過多症（ET）適應症自 9M26 開始貢獻；1-10M26 營收 226 億元，YoY +86%。3Q26 毛利率 96.8%，YoY +5.2ppts；營益率 40.3%，排除約 4.7 億元員工認購庫藏股費用後約 46.4%；EPS 7.08 元創單季新高，1-3Q26 EPS 18.43 元已達 2025 年全年的 1.5 倍
2. ET 已取得台灣、日本、美國、中國藥證，美日皆為全線適應症，韓國預計 2027 年初取證；真性紅血球增多症（PV）方面，Ropeg 於 NCCN 指南高、低風險皆列首選，競品 rusfertide 僅列註腳。我們認為 ET 可直接沿用 PV 既有的醫師網絡與用藥經驗，放量速度可望快於 PV 上市初期，為 2027 年營收成長主軸；公司目標 2027 年費用率降至 40 幾%，惟投資抵減用完後稅率將朝 20%靠近
3. 原發性骨髓纖維化（PMF）三期試驗 HOPE-PMF 已於 6M26 完成收案 160 人、9M26 通過資料安全監測委員會（DSMB）審查，目標 2028 年解盲送件，為第三個適應症；CML、HCC、AML、CTCL 等研究者發起試驗（IIT）持續延伸適應症。2026-2027 年多項 PEG 細胞激素、雙特異性抗體、ADC、MPN 標靶新藥與 TCR-T 目標申請 IND；竹北廠目標 2027 年投產

結論

我們認為藥華藥已進入 PV、ET 雙適應症驅動的成長階段，3Q26 在一次性費用干擾下營益率仍達 40.3%，營業槓桿持續發揮。我們看好 ET 藉 NCCN 首選地位與既有骨髓增生性腫瘤（MPN）醫師網絡加速滲透，帶動 2027 年營收增速持續高於費用；惟稅率回升將使淨利增幅低於營益。後續驗證點為 4Q26 首個 ET 完整季度貢獻、2027 年費用率能否降至 40 幾%，以及 2028 年 HOPE-PMF 解盲結果



請將您珍貴的一票投給凱基！

3Q26 財務表現

- 3Q26 營收 77.6 億元，QoQ +13%，YoY 近翻倍，YoY 增幅由 2Q26 約+90%擴大至接近+100%；成長來自美國與日本銷量成長、注射筆於美國上市，以及美日 ET 適應症自 9M26 開始貢獻
- 3Q26 毛利率 96.8%，YoY +5.2ppts，原因有三：
  - 美國、日本兩大高價值市場營收占比提高，產品組合優化
  - 美國藥價於 5M26 調升，3Q26 為首個完整反映的季度
  - 銷售以美元為主、成本以新台幣為主，新台幣較去年同期走貶

凱基投顧

陳宣甫
886.2.2181.8724
hsuan.chen@kgi.com

徐雋翔
886.2.2181.8745
kenny.ch.hsu@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

- 3Q26 營業費用 YoY +83%，主因認列員工認購庫藏股費用約 4.7 億元（非經常性），排除後 YoY +63%；費用率由 3Q25 的 61.6% 降至 56.5%，排除後約 50.4%
- 3Q26 營業利益 31.3 億元，YoY +168%；營益率 40.3%，YoY +10.4ppts，排除庫藏股費用後約 46.4%，與 2Q26 相當
- 3Q26 稅後淨利 29.2 億元，YoY +98%，淨利率 37.7%；淨利增幅低於營益，主因 3Q25 認列所得稅利益墊高基期。3Q26 有效稅率約 10%來自投資抵減，預計 2026 年大致用完，2027 年稅率朝 20%靠近
- 3Q26 EPS 7.08 元，YoY +97%，創單季新高；1-3Q26 營收 YoY +84%，營業利益 83.7 億元，YoY +149%，EPS 18.43 元，已為 2025 年全年 12.3 元的 1.5 倍
- 1-10M26 營收 226 億元，YoY +86%，2025 年全年營收為 157 億元

PV：NCCN 首選地位穩固

- 美國 MPN 病患約 34.7 萬人，其中 PV 約 16.3 萬人、ET 約 17 萬人、PMF 約 1.4 萬人；ET 人數隨診斷率提升持續增加
- PV 已擴展至全球約 50 國，2026 年取得加拿大藥證，後續包括墨西哥、越南、哥倫比亞
- NCCN PV 指南中，Ropeg 為低風險 PV 唯一首選療法、高風險 PV 唯一首選干擾素
- Takeda／Protagonist 的 rusfertide 於 2026/8/28 獲准用於 PV，但 NCCN 僅列於註腳：
  - 限頻繁放血或不耐受放血時使用，高風險病人只能 add-on 於現行治療
  - 機制為降低鐵的利用、只降低紅血球生成，不能取代細胞減量療法；Ropeg 試驗評估的完全血液學反應（CHR）涵蓋紅血球、白血球與血小板
- 低風險 PV 中 Ropeg 合併放血對照僅放血：治療反應率 81.3%對 50.8%，血球比容（Hct）控制 81.3%對 58.7%，疾病惡化 0%對 12.7%；KOL 愈來愈重視疾病修飾與早期治療，有助擴大可治療族群

ET：四國取證、全線適應症

- 過去 ET 用藥僅 Hydroxyurea（HU）與 anagrelide，臨床試驗中 Ropeg 對比 anagrelide 為 42.9%對 6%，達統計顯著
- ET 藥證：台灣 2026/5/12、日本 8/24、美國 8/28、中國 10/15 已取證；新加坡 10/12 送件；韓國預計 2027 年初取證
- 美日皆取得全線 ET 適應症（一線、二線病人皆可使用），後續各國送件亦朝全線方向；日本 ET 病患約 6.3 萬人、美國約 17 萬人
- Ropeg 注射筆已於美國上市並貢獻 10M26 營收，病人與醫師回饋

良好，有助提升病患留存與新病患採用

PMF 三期與適應症延伸

- HOPE-PMF 為隨機、雙盲、安慰劑對照三期試驗，2:1 分組，治療 80 週進行指標分析：
  - 6M26 完成收案，超收至 160 人
  - 9M26 通過 DSMB 審查，目標 2028 年解盲並送件
- PMF IIT 兩年數據：血液學反應率 W12 為 61.4%、W48 為 63.5%，其後達 70.0%；平均血小板由 512 降至 279（$\times 10^9/L$），W12 起即低於正常值上限
- IIT 延伸：CML（併用 dasatinib）一期／二期 IND 已獲核准、HCC（併用 anti-PD-1）一期數據已發表、AML 一期 IIT 進行中、CTCL 與 CMML 二期 IND 準備中、MF（併用 ruxolitinib）一期 IND 已提交；NCCN CTCL 指南已將 Ropeg 列為干擾素替代選項

早期產品線與產能

- 2026-2027 年多項產品目標進入臨床一期：
  - 雙特異性抗體 PD-1-IL-2v 預計 2026 年 IND
  - PEG-IL-2、PEG-Cytokines、ADC 與 KRAS TCR-T 預計 2027 年 IND
  - MPN 新藥 Type 2 JAK2 inhibitor 與 mCALR antibody 預計 2027 年 IND
- 已併購加拿大 FORUS，並於墨爾本設立營運據點推動臨床試驗；2026 年全球員工目標接近 1,000 人
- 竹北廠已進入製程設備安裝與機電管線整合階段，目標 2027 年投產；波多黎各廠設備均已下單，相關申請進行中

QA

- CMS 追溯調整何時認列完畢？
  - 2025 年 CMS 追溯調整預期於 2026 年處理完畢，剩餘金額較前兩次小；調整皆反映於營收，不影響營業成本
- 2027 年費用率如何展望？
  - 1-3Q26 費用率約 51%，2027 年 PV、ET 雙適應症帶動營收成長高於費用成長，目標費用率往 40 幾%邁進
  - 不提供推銷、管理、研發細項預估，建議參考 1Q-2Q26 的費用結構
- 稅率展望為何？
  - 3Q26 有效稅率 10%主要來自投資抵減，預計 2026 年大致用完，2027 年稅率朝 20%靠近

- 何時能達到規模經濟？
  - 3Q26 營益率 40.3%，國際大藥廠平均約 30%，前段班約 40-55%，禮來約 50 幾%，公司仍有優化空間
- 資本配置規劃為何？
  - 竹北、波多黎各廠依計畫擴建，並於美國購置不動產作為未來辦公室
  - 積極評估併購、少數股權投資與授權，並投資基金尋找合適標的
  - 在保留發展資金的前提下，以股利回饋股東
- ET 在美國的給付與藥價狀況？
  - ET 適應症已納入美國保險給付體系，處方採用持續增加
  - ET 與 PV 為同一產品，批發標價統一，實際淨價依各保險支付方的合約與回饋而異
- ET 成長速度是否會快於 PV？
  - 9M26 即有實質營收貢獻；MPN 醫師手上同時有 PV 與 ET 病人，且已熟悉 Ropeg 的安全性，加上醫學科學聯絡官（MSL）團隊支援，拓展速度將優於 PV 上市初期
  - PV 與 ET 互相帶動，並已耕耘社區醫院，加速處方滲透
- 是否考慮布局調控鐵的藥品？
  - 公司認為調控鐵僅降低紅血球生成，產業趨勢是疾病修飾、降低突變等位基因負荷，因此布局 Type 2 JAK2 與 mCALR 等標靶藥物
- Ropeg 在中國的定價策略？
  - 中國醫保走向較 commodity，為避免影響國際定價，目前以自費市場為主，並持續與主管機關溝通

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888 • 傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888 • 傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888 • 傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188 • 傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 JakartaSelatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股(OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有(N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股(U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等(NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制未評等(R)	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
	*總報酬= (十二個月目標價-現價)/現價

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。